

— BEGELEIDINGSGROEP 2 · 3 SEPTEMBER 2026

CareAlgent

AI die de administratieve last aan het bed
verlicht

Co-creatief onderzoek met zorginstellingen, technologiepartners en
onderzoekers — Blackbox, hybride · 9u–12u30



Waarom CareAlgent?

We onderzoeken hoe AI de administratieve last kan verlichten van de mensen aan het bed.

Die groep verliest vandaag veel tijd aan registratie; tijd die naar de patiënt zou moeten gaan.

Aan het bed

Focus op verpleeg- en zorgkundigen, niet artsen.

Co-creatief

Samen met zorginstellingen en technologiepartners.

Onderbouwd

Wetenschappelijk onderzoek in de échte zorgpraktijk.

Wat mag je vanochtend verwachten?

1 Nieuwe partners — wie zit er ondertussen mee aan tafel

3 Living labs — aanpak, stand van zaken

5 Bevraging begeleidingsgroep — markt, verwachtingen en tevredenheid

2 Resultaten voorbije periode — survey · co-creaties · literatuur · simulatie

4 Call for action — AI-ambassadeur, pilots, website & LinkedIn, timing

6 Netwerkreceptie

Wie is er ondertussen bijgekomen?



G2 Speech



Curavex



Artevelde Hogeschool



Thomas More

G2 SPEECH

DOING MORE WITH SPEECH

g2speech.com

Over G2



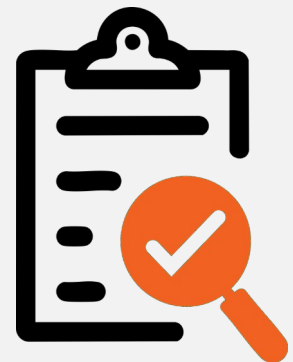
Jarenlange ervaring

Meer dan 25 jaar ervaring en wereldwijd actief



Compliance & security

Certificering & databeveiliging
ISO 27001, Medical Device
Class 1,...



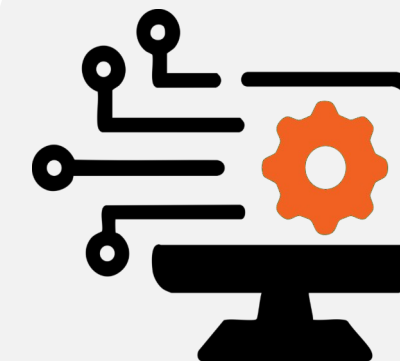
Administratielast in de zorg

Administratielast onder controle krijgen en tijd waardevoller besteden dmv **speech & AI technology**



Divers aanbod

Aanbod van diverse toepassingen om voor elke gebruiker de beste ervaring te garanderen



Interoperabiliteit

Integraties met verschillende EPD's, RIS en PACS en LIS-systemen

Op jacht naar... feedback



G2 SPEECH

DOING MORE WITH SPEECH



g2speech.com



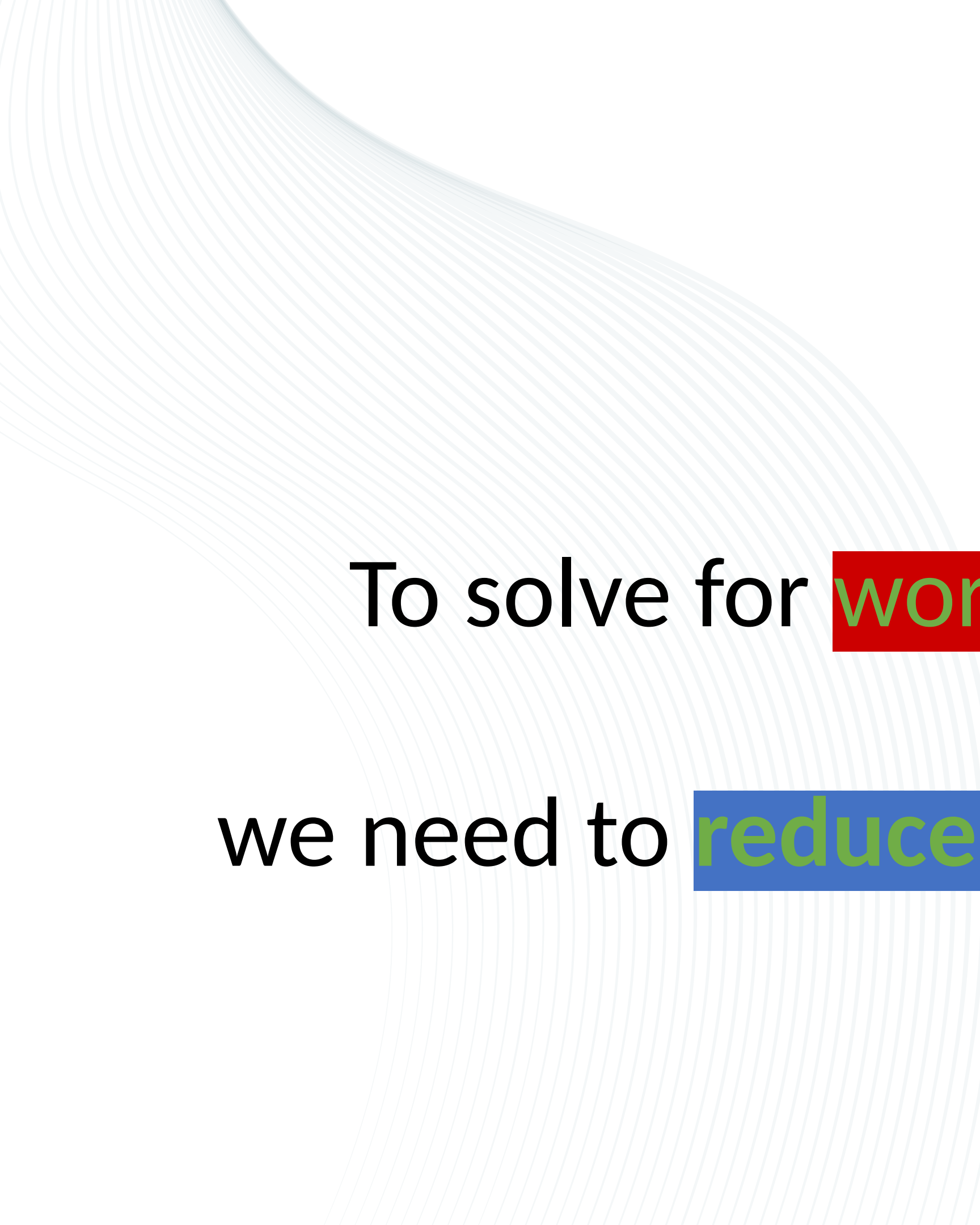
Saving hospitals €1M+ a year
by optimising daily nurse replacements
& boosting nurse job satisfaction



Scott Russell
+32 (0)468 28 12 41
scott.russell@innatify.com



Roel Verhaeren
+32 (0)472 83 11 04
roel.verhaeren@innatify.com



To solve for **workforce shortages**,
we need to **reduce daily admin** burdens

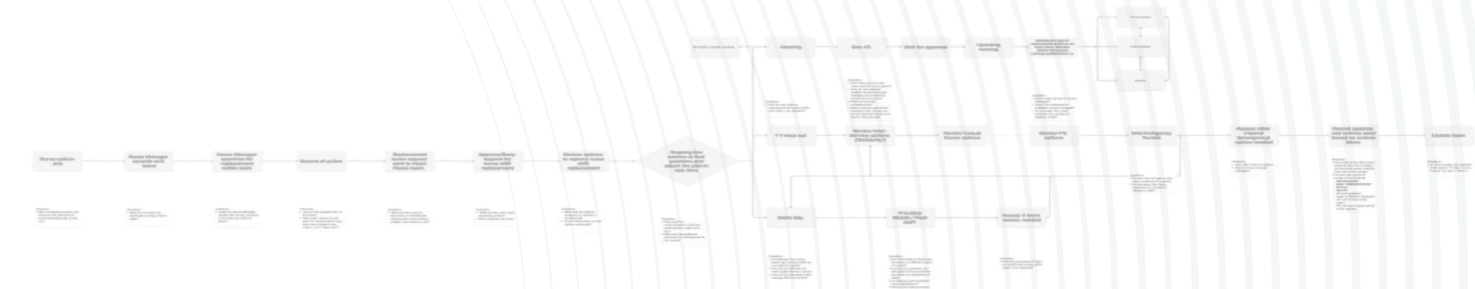
Digital transformation of complex daily staffing to deliver time, cost and care improvements

COMPLEXITY

Fragmented tools & report



Complex processes & procedures

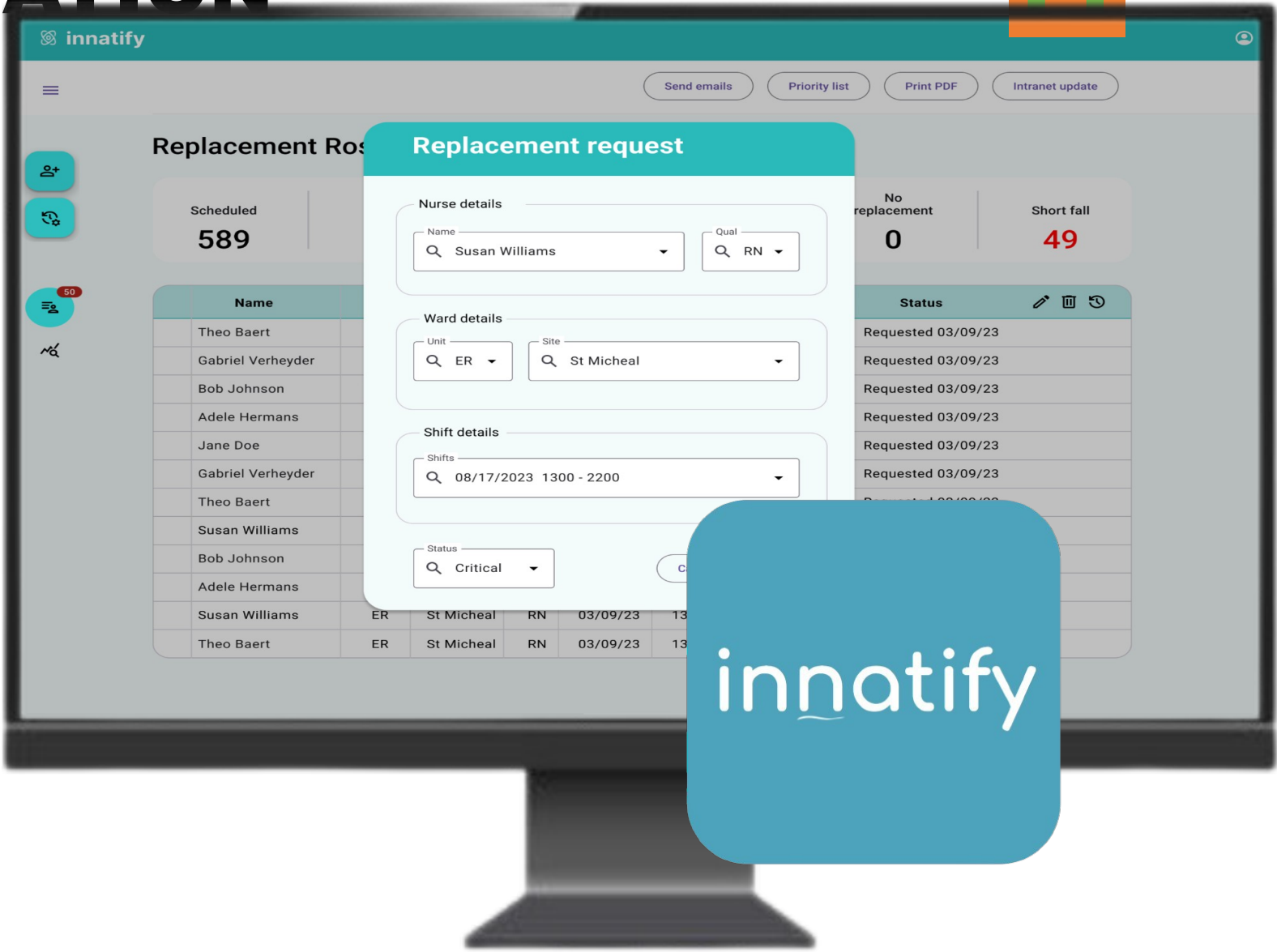


Significant weekly admin burden



DIGITAL TRANSFORMATION

SIMPLICITY



Building with the healthcare community



Wat is dVO?Abonneer nuAanmelden

dVO

de Vlaamse Ondernemer

OntdekZoek

INNATIFY B.V.

Innatify automatiseert personeelsplanning in zorgsector

18/07/2025 OM 17:11 - Luc Willemijns



(Scott Russell, oprichter Innatify)

De Belgische healthtech start-up Innatify B.V. (Aalst) lanceert een slimme digitale tool die het administratieve proces rond personeelsvervangning in ziekenhuizen vereenvoudigt. De oplossing richt zich op het verminderen van tijdsverlies en het verhogen van werktevredenheid binnen zorgteams en wordt reeds toegepast in onder meer Europa Ziekenhuizen.

Trends LIVE BELEGGEN

Trends VoorzedenShop itAbonneer

Trends ZBeleggenOndernemenGeld & ImmoAI & TechMacro & BeleidEventsVideoPodcasts

ONDERNEMEN

Starter van de week: Innatify verlaagt administratieve druk in zorgsector



Roel Van Espen

Medeoverner van Trends

18-07-2026, 10:30 • Bijgewerkt op: 21-07-2026, 15:40 • 1 min leestijd

Een tekort aan personeel, burn-outs en stijgende kosten zetten ziekenhuizen en andere zorginstellingen onder druk. De Brusselse start-up Innatify introduceerde daarom een planningsplatform dat automatisch in kaart brengt welke afdelingen versterking nodig hebben, welke zorgverleners beschikbaar zijn en welke kwalificaties of beperkingen daarbij gelden.

3 QUESTIONS POUR UNE START-UP

INNATIFY

Automatiser les tâches administratives

Innatify s'engage à réduire les effets de la pénurie de personnel infirmier qualifié dans les hôpitaux en développant une plateforme permettant de diminuer le fardeau administratif des équipes.

Quelles solutions innovantes proposez-vous?

La pénurie mondiale de personnel infirmier est un défi majeur et représente des coûts importants liés à la recherche de remplacements pour répondre aux besoins quotidiens en personnel. Notre plateforme alimentée par l'IA relève ces défis en exploitant des analyses de données avancées et un logiciel convivial pour automatiser les tâches administratives. Cette automatisation permet aux équipes de soins de se concentrer sur les soins aux patients. Elle facilite une meilleure prise de décision en fournissant des insights précieux et des recommandations optimales. Cela se traduit par des économies de temps et de coûts, améliore la satisfaction du personnel infirmier et favorise l'adoption des meilleures pratiques.

Quel élément vous a aidé à créer un partenariat avec les hôpitaux?

Les partenariats hospitaliers à long terme reposent sur des contacts solides et une résolution proactive des problèmes. L'accent est mis sur «Quels défis rencontrez-vous?». Notre motivation principale vient d'une sensibilité personnelle aux métiers de soins: sœur infirmière et amis proches travaillant dans des hôpitaux. Nous mettons l'accent sur la planification et la recherche pour soutenir des horaires serrés et des contraintes de ressources. Notre approche implique une compréhension approfondie des opérations hospitalières, ce qui nous permet de relever les défis et d'anticiper les besoins futurs, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et le bien-être des équipes. Pour garantir un succès mutuel, nous alignons nos objectifs et partageons les risques.

Que proposez-vous pour le suivi?

Pour garantir la pertinence de nos solutions, nous nous concentrons sur les stratégies suivantes: établir et réviser régulièrement des indicateurs de succès clairs, prioriser l'écoute active et nous engager dans l'innovation continue. Cette approche garantit que nous restons réactifs aux réglementations évolutives et aux besoins des hôpitaux et que nous répondons aux demandes futures.

Plus d'infos:

www.innatify.com
scott.russell@innatify.com

Automatiseren van administratieve taken

Innatify engageert zich om de gevolgen van het tekort aan geschoolde verpleegkundigen in de ziekenhuizen aan te pakken. Daartoe hebben ze een platform ontwikkeld dat de administratieve lasten voor verpleegteams vermindert, waardoor deze zich beter kunnen concentreren op de patiëntenzorg.

HOSPITALS-net - 2024

31



De AI assistent voor zorgmedewerkers

van Studio 55



Veel informatie. Te weinig antwoorden.

Zorgmedewerkers besteden **dagelijks 30 tot 90 minuten** aan het **zoeken** naar informatie verspreid over verschillende systemen, documenten en websites.

Medewerkers richten zich steeds meer naar publieke chatbots om tijd te winnen.



De data-layer voor zorgkennis



Op maat van zorgorganisaties

Virtas werd ontwikkeld in samenwerking met honderden zorgmedewerkers, om precies te passen in hun dagelijks werk



afgeschermd en beveiligde omgeving



bestaande login & wachtwoord



mobiele app, website of widget



geschreven of spraakgestuurd



eigen huisstijl



Automatic feedback loops

Inzicht in je eigen data



Ontdek hoe kennis wordt gebruikt in jouw organisatie

- Controle over de kwaliteit van de antwoorden
- Inzicht in de meest bevraagde thema's
- Detectie van problemen in datakwaliteit

Contact

François Gerard

francois@studio55.ai

+32 499 57 77 51

www.studio55.ai

Studio 55

AI tools for less admin and more
care

RESULTATEN

Wat leverde de voorbije periode op?

Survey



Co-creaties



Literatuur



Simulatie

Twée metingen in 2026

METING 1 • JANUARI

Sectorbevraging

Hoe stond men vanuit de zorg tegenover AI?

202 respondenten uit de Vlaamse zorgsector:
ziekenhuizen, woonzorgcentra, eerstelijns en GGZ.

METING 2 • JUNI

Simulatie in PXL

Studenten en lectoren werken met Odilon en 82care

24 deelnemers testen twee use cases in een
gesimuleerde zorgsetting, met een voor- en een
nameting.



De wil is er, het gebruik nog niet

202

Zorgprofessionals
bevraagd

51% zorgprofessional
52% ziekenhuis

35%

Gebruikt AI voor
administratie

22% actief
13% in testfase

86%

Wil AI gebruiken
(niet-gebruikers)

97 van 113
de wil is er

65%

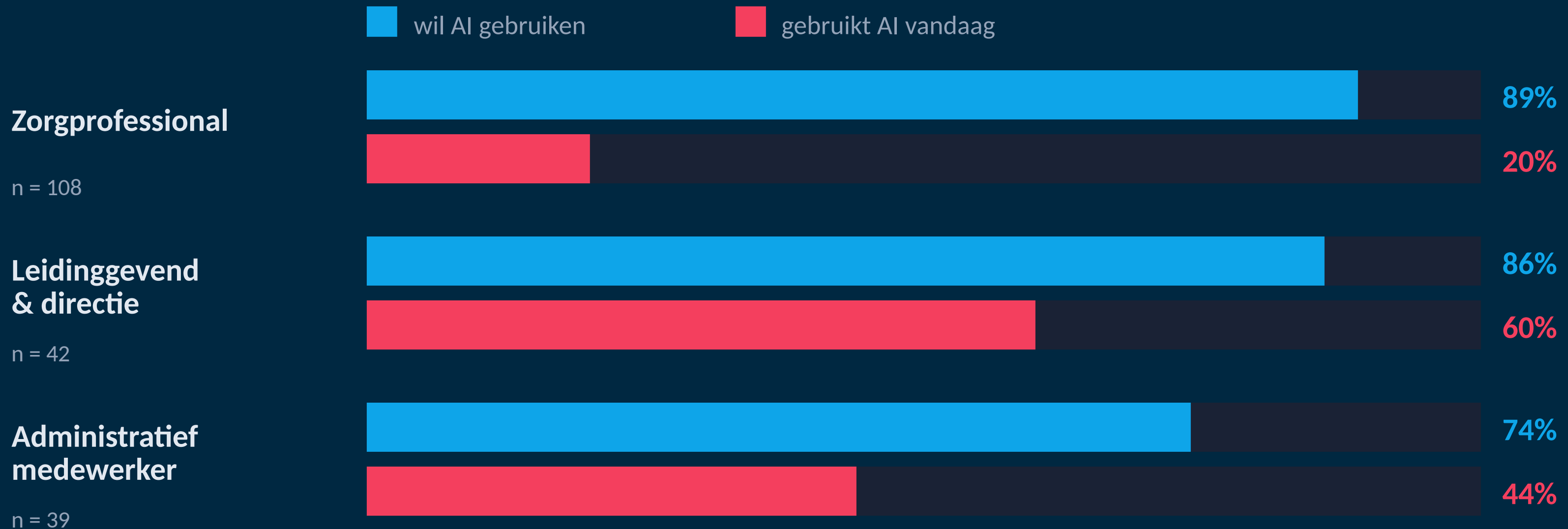
Ziet hoog of
zeer hoog potentieel

53% hoog
13% zeer hoog

Slechts 6 respondenten konden ervaren voordelen benoemen — het gebruik is nog te jong om effecten te meten.



Dichter bij de patiënt, minder AI



GROOTSTE KLOOF

Zorgprofessionals willen AI het meest en gebruiken het minst. Ook per organisatietype: ziekenhuizen 84% wil / 25% gebruikt, andere instellingen 88% / 46%.



Kennis is de drempel én de vraag

GROOTSTE DREMPELS



GEVRAAGDE ONDERSTEUNING



Meerdere antwoorden mogelijk • n = 202



Wat de sector het liefst wil

Tekst- en rapportgeneratie



Automatische planning en roostering



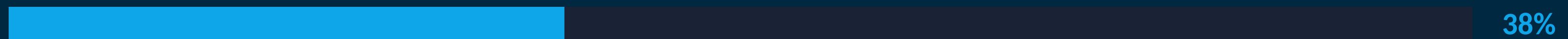
Administratieve workflowoptimalisatie



Automatische dataverwerking of coding



Beslissingsondersteuning



Twée sessies, bewust apart

Technologiepartners

17 februari 2026

Facilitatie Robin Schrijvers & Joachim Gregoor. 11 deelnemers: aanbieders van AI-scribes en integratoren (o.a. Spikes/A2Care, Cavell, Autoscriber, Curavex, ClarityTalk, NextGen).

Zorgpartners

24 februari 2026 · Europaziekenhuis

Facilitatie Eric Lodewyckx & Isabel Kortleven. 15 deelnemers uit thuiszorg (Wit-Gele Kruis Limburg & Antwerpen), ziekenhuizen (AZ Groeninge, AZ Oostende, AZ Maria Middelaes, AZ Voorkempen), gespecialiseerde zorg (Fiola, Mintus) en zorggroep Arum.

METHODIEK

Miro-board met private post-it-fase → clustering → plenaire synthese, aangevuld met root cause analyse (5× waarom), het 4D-model (Discover–Dream–Design–Destiny) en ADKAR voor het verander- en compliance-luik.

Waarom apart: eerst technologie-aanbod en zorgnoden afzonderlijk scherp krijgen, daarna matchen.

Wat vertelt de zorgkant?

- 1 Administratieve last & registratiedruk** — met afstand het hoogst geprioriteerd. Documentatie gaat ten koste van directe zorg; veel dossierinhoud dient controle en financiering, niet de zorg. Pijnpunt: wie terugkeert na afwezigheid moet meerdere dagboeken doorworstelen.
- 2 Complex & versnipperd zorglandschap** — informatie in silo's, soms 15+ systemen, geen single source of truth, gebrekkige interoperabiliteit (HL7/FHIR). Ook een patiëntveiligheidsprobleem.
- 3 Implementatiebarrières** — weerstand op de werkvloer, te weinig betrokkenheid van eindgebruikers, onduidelijke scope, beperkte interne capaciteit, en shadow AI.
- 4 Personeelsschaarste & digitale geletterdheid** — structureel tekort, hoge werkdruk, sterk uiteenlopende AI-geletterdheid.
- 5 Beperkte middelen & onderfinanciering** — ROI moeilijk hard te maken; POC-kost vaak niet transparant t.o.v. volledige uitrol.

Drie inzichten die blijven hangen

Registratie vs. klinisch denken

Als AI het dossier vult, denkt de zorgverlener misschien niet meer zelf na. "Human in the loop" is geen technisch detail maar een kwaliteitswaarborg.

Survey:

Human in the loop –
automatisatiebias – ethiek –
privacy – patiënt transparantie
- opleidingbehoefes

Deconnectie-risico

Hoe meer digitalisering, hoe groter het gevaar dat mens en scherm niet meer los te koppelen zijn.

Survey

Mens- AI-interactie – workflow
(AI- ZV – pat)

De business case

≈ €400.000

per jaar (opportuiniteitskost)

10 minuten tijdswinst per medewerker per dag × 400 medewerkers. Een sterk argument richting directies.

Waar de vraag samenkomt

MEEST GEVRAAGDE USE CASES

- Speech-to-text met EPD-integratie
- Intelligente overdrachtstool
- Gespreksgestuurde verslaggeving / anamnese

Niet toevallig ook de meest kansrijke living-lab-startpunten: breed gedragen, meetbaar, beperkt klinisch validatierisico.

SELECTIECRITERIUM

Gebruiksvriendelijkheid en klinische inbedding wegen zwaarder dan technische perfectie.

Een tool die naadloos in de workflow past en tijd bespaart, scoort hoger dan een technisch superieure maar complexe oplossing.

Wat vertelt de technologiekant?

HET EPD ALS "KINGMAKER"

In België zijn EPD-leveranciers niet wettelijk verplicht om integratie toe te staan. Zonder EPD-integratie komt geen enkele AI-tool structureel van de grond. Dit blijkt het grootste structurele obstakel in de Belgische zorgmarkt. Hefboom: vraag stimuleren vanuit zorginstellingen richting hun EPD-leverancier.

Only-once-principe — één keer registreren (bij voorkeur via spraak) en automatisch laten doorstromen naar alle relevante systemen. De "heilige graal".

Minder vs. beter registreren — standpunt A (schrappen kan) vs. B (registratie is waardevol mits efficiënt). Synthese: procesherdenking + technologie samen.

De "witte raaf" — AI Compliance Officer / Center of Excellence: transversale, ondersteunende rol. In de praktijk nog nauwelijks tegengekomen.

GDPR-reflex als rem — sinds GDPR veel "in een kramp" dichtgetimmerd. De sector moet leren omgaan met onzekerheid.

Only-once-principe: naar een MAS-aanpak

In de praktijk zijn oplossingen vandaag **use-case gebonden**. Idealiter wordt de context van de spraakingave **eerst ingeschat**, de informatie **terloops bijgehouden**, en pas **ná de inschatting weggeschreven** op de juiste plaats in het EPD.



Compliance-checklist vóór een pilot start



Duidelijke RACI



DPO & CISO vroeg betrekken



DPIA uitvoeren en documenteren



Meetbare KPI's



C-level-mandaat



AI Act concreet maken voor de use case



Bestaande protocollen gebruiken (DPA Zorgnet-Icuro)

Waar vraag en aanbod elkaar raken

- 01 Technologie is zelden het echte obstakel.** Weerstand, cultuur, scope en betrokkenheid bepalen succes — in beide sessies onafhankelijk bevestigd.
- 02 Duidelijke convergentie** rond speech-to-text / AI-scribes met EPD-integratie — daar raken zorgnood en aanbod elkaar het sterkst.
- 03 Harde randvoorwaarde:** EPD-integratie én het only-once-principe.

— CO-CREATIES • KANTTEKENING

Waarom ons eigen onderzoek nodig blijft

Een aantal aanbieders leunt sterk op zelf-gerapporteerde gebruikscijfers en implementaties **bij artsen**. Het CareAlgent-onderscheid is net de focus op **verpleeg- en zorgkundigen aan het bed** en focust zo op een groep die in de bestaande tools en evidentie ondervertegenwoordigd is.

Wat is er technisch gedaan?

Gesimuleerde zorgomgeving

Ziekenhuis- en woonzorgomgeving met realistische patiëntcontacten: opname- en anamnesegegesprek, wondzorg, acute achteruitgang. Meerdere patiënten op verschillende kamers — géén sequentiële consultaties.

Spraak naar tekst

Spraak-naar-tekst met automatische vulling van gestructureerde velden.

Verwerking

Debriefing per groep én overkoepelend; transcripten en notities verwerkt tot één thematische synthese.

De API's werkten — maar onder drie beperkende condities

01

Gesloten testomgeving

Aparte logins per toestel en eenmalig bruikbare 2FA-links, geen SSO. De authenticatielaag zoals in productie is dus **niet** getest.

02

Beheersbare patiëntenset

Identificatie op naam via een combobox. Twee patiënten "van de Berg" volstonden al voor verwarring; in een echt ziekenhuis is dat de norm, niet de uitzondering.

03

Eén formulierstructuur

Geen afdelingsspecifieke anamneses (oncologie vs. orthopedie), geen dialect, geen achtergrondgeluid.

Wat is er écht getest?

KETEN A — GETEST



KETEN B — NIET GETEST



Getest is de keten spraak → tekst → veld. Nog niet de keten tot juiste patiënt, juist dossier en juiste verantwoordelijke.

Waarom een koppeling met een écht EPD een ander verhaal is

Datamodel

De translatie van gesproken data (bv. lichaamsgewicht) naar het correcte EPD-veld is nog onduidelijk. Elk EPD heeft een eigen veldstructuur en validatieregels.

Identificatie

Een koppeling vereist een harde identifier (patiëntnummer, patiëntbandje scannen, of kamer + tijd + locatie), niet een naamselectie. Zonder patiëntnaam kan een opname zelfs niet aan een dossier gekoppeld worden.

Accountability

De registratie staat op naam van de zorgverlener. Op gedeelde toestellen zonder rol- en accountbeleid ontstaat misattributie — een **juridisch** vraagstuk, geen technisch.

Promptgovernance

De leverancier legt sjablonen en afdelingsspecifieke prompts bij de zorginstelling. Outputkwaliteit wordt een **organisatorische** verantwoordelijkheid, niet iets dat je aankoopt.

Hoe onderzoeken we adoptie en implementatie?

FASE 1 — ADKAR

Via de simulatie brengen we de adoptiefactoren in kaart met het ADKAR-model (**A**wareness, **D**esire, **K**nowledge, **A**bility, **R**einforcement). Zo krijgen we vroeg zicht op de grootste drempels voor zorgverleners en patiënten, nog vóór de tool in een pilot draait. Die inzichten gaan mee naar opleiding en begeleiding bij de echte implementaties.

FASE 2 — NORMALIZATION PROCESS THEORY

Daarna onderzoeken we hoe de tool zich normaliseert in de dagelijkse praktijk: kwantitatief via de **NoMAD-vragenlijst** en kwalitatief via **sense making-sessies** met de participanten.

Wat wilden we leren?

Doel

Lessen trekken uit de use-case-simulatie (debriefings) voor de implementatie-aanpak richting de echte use cases, waar AI-software in reële ziekenhuisomgevingen getest zal worden.

Setting (belangrijk voor de interpretatie)

Een afdeling met meerdere patiënten die op verschillende kamers zorg krijgen. Dus géén sequentiële consultaties.

De vijf stappen, kort

Awareness

Sterke schakel bij de zorgverlener: doel wordt begrepen (minder admin, minder scherm, meer patiëntcontact). Wringt richting de **patiënt** (informed consent).

Desire

Aanwezig, maar voorwaardelijk en fragiel: vertrouwen moet groeien, peers overtuigen, aandacht voor patiënt

Knowledge ⚠

Onduidelijk wat de tool automatisch registreert vs. wat je zelf hardop moet benoemen; praktische kennis (microfoon, opnameknop, identificatie, dialect) ontbrak.

Ability ⚠

Vlot en betrouwbaar uitvoeren lukte niet: velden "kunnen" vs. "moeten" invullen, luidop benoemen niet altijd gewenst, onduidelijk wie wat zei.

Reinforcement

Moeilijk te testen in een eenmalige simulatie; signalen: naam van de validerende zorgverlener registreren, nood aan een eindverslag/dagafsluiting.

— SIMULATIE • ADOPTIE

Waar het wél klikt

"Fijn dat ik gewoon kon praten met de patiënt en dat ik niet heel de tijd moest noteren. Patiënt kan zich zo meer gezien voelen."

Wat nemen we mee naar de living labs?

Los eerst Knowledge & Ability op — kort, praktijkgericht opleidingstraject (peers/super-users): wat capteert de tool, wat moet mondeling, hoe werkt opnameknop/microfoon/identificatie.

Bescherm Desire — klein beginnen, vrijwilligheid behouden, interne ambassadeurs, vroege zichtbare successen; tool = hulpmiddel, geen vervanging van klinisch redeneren.

Laat het ook echt kloppen — niet "meer tijd voor de patiënt" beloven terwijl het erop neerkomt dat alles sneller moet. Dat zou reinforcement in de weg staan.

Kies de eerste pilotcontext zorgvuldig — grootste meerwaarde, laagste risico: anamnese, daghospitaal (bv. pediatrie), of WZC met dezelfde patiënten. Eerst doorontwikkelen vóór brede uitrol.

Werk de patiëntkant van Awareness uit — herbruikbaar informed-consent-protocol + korte uitleg voor patiënten (wat wordt opgenomen/verwerkt, hoelang, wat met gevoelige info).

Regel dossiervalidatie — wie is verantwoordelijk voor de validatie, en kan dit getrackt worden? Cruciaal voor kwaliteit, betrokkenheid en verankering.

24 deelnemers, twee use cases

24

deelnemers

15 studenten · 9 lectoren

2

groepen

elke groep testte beide use cases

5

bedienden de tool zelf

de andere 19 waren observator of patiënt

USE CASE 1 · ANAMNESE

Een anamnesegeprek met een patiënt, terwijl 82care meeluistert en de informatie zelf invult in Odilon, het elektronisch patiëntendossier.

USE CASE 2 · DICTEREN

Observaties en parameters inspreken bij 82care, dat ze vervolgens in Odilon plaatst.

Wat is vóór en wat is ná gemeten?

8 VRAGEN • VÓÓR DE SIMULATIE

- functie, leeftijd, opleidingsjaar
- ervaring met digitale werkinstrumenten
- ervaring met AI-tools

"Ik sta over het algemeen open voor het gebruik van nieuwe digitale tools" **84% eens**

"Ik maak me zorgen over de betrouwbaarheid van AI-gegenereerde tekst" **20% eens**

60 VRAGEN • NA DE SIMULATIE

- beoordeling van 82care: aanvaardbaarheid, passendheid, haalbaarheid
- kwaliteit van de AI-tekst en opgemerkte fouten
- verwachte tijdswinst
- vertrouwen, controle en privacy
- opleidingsbehoefte en een globaal cijfer

Hoe beoordeelden ze de tool?

5,75

Globaal cijfer op 10

Gestelde vraag: "Geef de tool een globaal cijfer: 1 (zeer slecht) tot 10 (uitstekend)."

mediaan 6 · laagste 4 · hoogste 7 niemand geeft 8 of meer

DRIE SCHALEN, 12 ITEMS · SCHAAL 1 (HELEMAAL ONEENS) — 5 (HELEMAAL EENS)

Aanvaardbaarheid

3,41

Passendheid

3,42

Haalbaarheid

3,24

HET SCHERPSTE CONTRAST BINNEN DEZELFDE SCHAAL

«de tool ...» vind ik
aanvaardbaar 15 van 24 eens

3,71

«de tool ...» is
goed 5 van 24 eens

2,96

Outputkwaliteit is de rem

21/24

benoemde een concrete fout uit de simulatie

"De gegenereerde tekst was voldoende volledig" scoort **2,33 op 5** — het laagste item van de hele nameting. 16 van 24 was oneens.

8× Informatie ontbrak in het dossier

6× Verkeerde numerieke waarde (4× het gewicht)

4× Semantische transcriptiefout ('wonde' → 'zone')

3× Verkeerd patiëntdossier geopend

2× Allergieën gemist

2× Medicatie niet genoteerd

Weten wat je moet controleren

GESTELDE VRAAG

"Ik wist op elk moment wat ik kon vertrouwen en wat ik moest controleren."

2 eens

13 neutraal

9 oneens

9 van 24

zag fouten én kon niet inschatten wat te controleren

DE EIGENLIJKE RISICOGROEP

19 van 24

wil meer leren over de beperkingen en risico's van AI

"... bijv. hallucinaties, bias" — 3,96 op 5

19 van 24

ziet meerwaarde in een training kritisch denken over AI-output

3,88 op 5

Twée punten om nu mee te nemen

TIJDSWINST

5,29 /10

"Hoeveel tijdswinst verwacht je van deze AI-tool?"

6,58 /10

"Hoeveel moet een AI-tool minstens opleveren om het te willen gebruiken?"

14 van 24 verwacht minder tijdswinst dan ze zelf nodig vinden; 18 van 24 verwacht eerst een leercurve.

PATIËNTTRANSPARANTIE

20 / 24

"Ik vind het belangrijk dat de patiënt weet dat een AI-tool meeschrijft."

Met 4,12 op 5 is dit het breedst gedragen standpunt van de hele námeting. Maar wie de tool het liefst wil gebruiken, geeft er juist het minste gewicht aan.

Enthousiasme vooraf bepaalde de wil, niet wat men zag

Voormeting-vraag: "Ik sta over het algemeen open voor het gebruik van nieuwe digitale tools in mijn werk of opleiding" (1–5)

Nameting resultaat

WAT ZE VONDEN

Wil een AI-tool zoals 82care aanbevelen aan collega's

Denkt dat men het systeem graag regelmatig zou gebruiken

WAT ZE VASTSTELDEN

Vond de AI-tekst inhoudelijk correct

Vond de AI-tekst voldoende volledig

Vooraf zeer positief	Vooraf neutraal tot positief
n = 13	n = 11
3,85	3,09
3,92	2,82
2,62	2,91
2,38	2,27

CONCLUSIE Enthousiasme vooraf bepaalde of iemand de tool wíl, niet wat iemand vaststelde. Beide groepen merkten even veel fouten en vonden de AI-tekst even onvolledig.

— SYNTHESE

Van intentie naar praktijk

01

De wil is niet het probleem

Januari: 86% van de sector wil AI gebruiken. Voormeting juni: 84% van de deelnemers stond open voor nieuwe digitale tools.

02

De uitvoering is het probleem

Námeting: globaal cijfer 5,75 op 10, 21 van 24 zag een concrete fout, en de volledigheid van de AI-tekst scoort 2,33 op 5.

03

Draagvlak lost dat niet op

Deelnemers die vooraf enthousiast waren, zagen dezelfde fouten en beoordeelden de tekstkwaliteit gelijk.

04

Informatie living labs

Aanpak · stand van zaken · integratiekost

Hoe pakken we de living labs aan?

1

Simulatie bij PXL

Odilon-EPD (waar we nu staan)

2

Living labs, iteratie 1–2

Bij zorginstellingen, agile iteraties van 3–4 weken (testmoeheid slaat toe na 2–3 weken)

3

Living labs, opschaling

Bredere inzet na gevalideerde iteraties

4

Validatie

van het implementatiekader

RANDVOORWAARDEN

Minimaal 4 weken testen · ~10 zorgverleners per site · één intern aanspreekpunt · echte FTE-tijd · een (symbolische) financiële buy-in — gratis testfases leiden tot lage betrokkenheid.

Zo verloopt een living lab

Het **onderzoeksdesign is identiek** in elk lab; de technische opzet niet — KWS-geïntegreerd of stand-alone, ziekenhuis of woonzorg. Voorbeeld: AZ Voorkepen.

EÉN VAST MEETINSTRUMENT

Leidraad Dataverzameling

- AIM / IAM
- NoMAD + human-in-the-loop
- Tijdsbeleving
- Datakwaliteit
- Ethische dimensies

TWEE RESPONDENTENGROEPEN

Zorgprofessionals

15–25

Gebruikers · adoptie & ervaring

Sleutelfiguren

3–6

Technisch/organisatorisch · proces, integratie, governance

De iteratie in 3–4 weken

Vorbereiding	Contracten, ethisch comité, AI Act/MDR-kwalificatie, technische onboarding, templates
Week 1	Gebruikersonboarding (± 1 u) + T0 vóór en T1 na de onboarding
Week 1–3	Actief gebruik, geen extra registratielast; incidenten en afhakers opgevolgd
Week 3–4	T2-nameting, interviews gebruikers (15–20 min) + stakeholders (30–45 min)
Afsluiting	Terugkoppeling; vaststellingen worden aanpassingen in de volgende iteratie

→ **Concept valideren:** een beperkte, voorspelbare use case (anamnese, consultatieverslag). Werkt de meetketen?

Rolverdeling in een living lab

WAT WE VRAGEN VAN DE INSTELLING

- Eigen use cases kiezen — de instelling bepaalt waar de tool zinvol is
- Interne beslissingsnemer (innovatie/staf) + ICT-verantwoordelijke
- Key users + 15–25 vrijwillige deelnemers
- ICT-voorbereiding en templates vóór start (met leverancier)
- Eigen ethisch comité doorlopen (wij leveren protocol + bijlagen)
- Beperkte tijdsinzet: onboarding ±1u, 3×10–15 min vragenlijsten, interview optioneel
- Contracten en integratiekost bij instelling en leverancier

WAT PXL OP ZICH NEEMT

- Onderzoeksopzet, meetinstrument en dossier ethisch comité — aangeleverd
- Kickoff + gebruikersonboarding samen met de technologiepartner
- Vaste driehoek instelling × technologiepartner × PXL
- Meting en interviews; incidenten en afhakers lopend opgevolgd
- Terugkoppeling na elke iteratie — concrete aanpassingen
- Rol = onderzoeker, geen beoordelaar; enkel geaggregeerde rapportering

Wat het de instelling oplevert

Onafhankelijke cijfers over de eigen organisatie: een gevalideerd meetinstrument in de eigen setting.

Geobjectiveerde tijdswinst, incl. validatietijd van de arts — bruikbaar in een aankoop- of investeringsdossier.

Zicht op adoptie en weerstand vóór een brede uitrol: wie gebruikt het echt, wie haakt af en waarom.

Aandacht voor niet-artsberoepen (verpleegkundig, paramedisch, administratief) — vaak een blinde vlek.

Gedeelde onderhandelingspositie op de integratiekost doordat meerdere instellingen samen optreden.

Toegang tot het implementatiekader en de andere cases via het lerend netwerk.

Waar staan we vandaag?

Simulatiefase

DOORLOPEN

82Care-platform met studenten uitgewerkt.

AZ Voorkampen × Cavell

**START OKT
2026**

- Ethisch comité ingediend
- 15–25 deelnemers, 5 weken
- kickoff 7/10
- KWS-onboarding 14/10
- gebruikersonboarding 20–22/10
- contracten klaar (legal documents, overeenkomsten)
- Nog overleg voor finale afklopping.

AZ Oostende

OKT–NOV

Gesprekken met Cavell gepland. Beoogde timing oktober–november.

Mintus

VOORJAAR 2027

AI-plannen met intern platform Cevi Care (Feline+): speech-to-text; positief onthaalde demo's. WZC Ten Boomgaarde en Van Zuylen (Brugge) ter sprake. Testen voorjaar 2027 (nieuwe release); contracten in opmaak.

G2Speech

DECEMBER

Mogelijk ook een pilot met G2Speech die we zouden kunnen opvolgen, gepland in december — gesprekken lopende.

— LIVING LABS • KOSTEN

Transparant over de kosten

De kost van Nexushealth is de kost om **KWS open te stellen** zodat agents erop kunnen werken (opzet MCP, velden van extern invullen) -> de **opstartkost**. Na navraag kan PXL hierin niet tussenkomen.

De kost wordt gedragen door de zorginstelling.

05

Call for action

Ambassadeur · pilots · zichtbaarheid · timing

Onze AI-ambassadeur

We voorzien een **train-de-trainer-opleiding** : deelnemers worden zelf ambassadeur en trekker van verantwoord AI-gebruik op de eigen werkvloer.

88%

wil AI gebruiken

65%

ziet een hoog potentieel

35%

gebruikt AI vandaag actief

→ De kloof zit niet in de wil, maar in **kennis en implementatieondersteuning** . De AI-ambassadeur vult die kloof binnen de eigen zorgorganisatie. CareAlgent-onderzoek 2026 · 201 zorgprofessionals

Wat leert een AI-ambassadeur?

01

Kennis

Wat AI en generatieve AI wél en niet kan in een zorgcontext.

02

Verantwoord gebruik

Privacy, GDPR, betrouwbaarheid, ethiek en grenzen.

03

Praktische integratie

AI concreet inzetten om administratieve last te verlagen.

PROGRAMMA-ONDERDELEN

- Introductie AI & generatieve AI in de zorg
- Verantwoord & veilig gebruik: privacy, GDPR, kritische blik
- De rol van ambassadeur: collega's meenemen en opleiden
- Administratieve last: waar wint AI tijd?
- Hands-on: prompten en concrete tools uitproberen
- Actieplan voor de eigen dienst/organisatie

DOELGROEP

Zorgprofessionals uit de Vlaamse zorgsector die binnen hun organisatie het voortouw willen nemen in verantwoord AI-gebruik en collega's willen begeleiden.

Schrijf je in voor de vorming

Train-de-trainer · halve dag · praktijkgericht · kleine groep

SESSIE 1

22 september 2026

09:00 – 13:00 · PXL NEXT

Plaatsen **13**

Inschrijven vóór **15 sep 2026**

SESSIE 2

25 februari 2027

09:00 – 13:00 · PXL NEXT

Plaatsen **15**

Inschrijven vóór **18 feb 2027**



Scan & schrijf je in
careagent.be/agenda

Eric.Lodewyckx@pxl.be

— CALL FOR ACTION

Wie stapt in als living lab?

Oproep tot pilots die de **tech-aanbieders zelf** doen bij zorginstellingen. Wij haken er graag mee aan met ons onderzoek.

VELE VOORDELEN



Onafhankelijke meting van tevredenheid



Inspraak in de vragenlijsten



Tailoren naar eigen noden



Inzichten geven



Effort door onderzoeksexperten



Kwalitatieve vragenlijst



Implementatie versnellen in de toekomst

→ **Melden bij Robin of bij Eric!** Eventueel kunnen we ook helpen om zorginstellingen in contact te brengen met tech-aanbieders.

— CALL FOR ACTION

• Eric

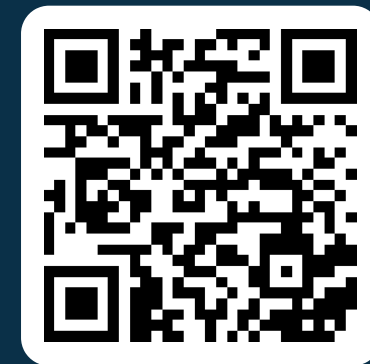
Help ons zichtbaar maken

Deel en volg CareAlgent.



Website

careagent.be



LinkedIn

linkedin.com/company/careagent

— CALL FOR ACTION

Komende timing



— BEVRAGING BG

We horen graag van jullie

01 Markt

02 Verwachtingen

03 Werking

Wat vangen jullie op in de markt?

Marktontwikkelingen

- Welke nieuwe features of tools in AI-scribes / administratieve ondersteuning moeten wij zeker kennen?
- Grote ontwikkelingen bij EPD-leveranciers rond integratie (API's, FHIR)?
- Iets gezien op beurzen of events dat relevant is voor de living labs?

Contacten & netwerk

- Met welke zorginstellingen of technologiepartners zijn jullie zelf in gesprek?
- Kennen jullie kandidaat-instellingen die geschikt zijn als living lab?

Beleid & regelgeving

- Signalen rond AI Act, MDR of GDPR-interpretatie die voor onze use cases relevant zijn?

Welke rol zien jullie voor jezelf?

- 1** In welke rol het komende jaar: **actief meedraaien** in een living lab, **meelezen/adviseren** , of vooral **op de hoogte blijven**?
- 2** Wat zou voor jullie een reden zijn om als **pilot** in te stappen — en wat houdt jullie tegen?
- 3** Wat verwachten jullie concreet van CareAlgent om zelf stappen te zetten? (kader, tools, benchmarking, juridische templates ...)

Hoe loopt de begeleidingsgroep zelf?

→ Tevredenheid over inhoud en frequentie van de begeleidingsgroep?

→ Voelen jullie je voldoende betrokken bij de richting van het project?

→ Wat mist er, wat kan beter?

→ Is het format (hybride, duur, opbouw) werkbaar?

— BEVRAGING BG

Vul aan op het Miro-board

De vragen van de drie blokken staan klaar — schrijf mee tijdens de sessie.



Scan en schrijf mee

- Blok 1 — wat vangen jullie op in de markt?
- Blok 2 — welke rol zien jullie voor jezelf?
- Blok 3 — hoe loopt de begeleidingsgroep zelf?

miro.com/app/board/uXjVHrrWUL8=

— TOT SLOT

Bedankt — en tot straks

We sluiten af met een netwerkreceptie. Volop tijd om verder bij te praten.

• **CareAlgent** Contact · website · LinkedIn — aan te vullen

CareAlgent Begeleidingsgroep

03/09/2026 —

Tevredenheidsenquête

